

Главная / Блог / Травма колена

Травма колена

СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА

29 июля 2021



Феськова Татьяна
Николаевна

Терапевт

Содержание

1. Причины травм коленного сустава
2. Какие бывают травмы колена: наиболее распространенные случаи

6. Упражнения для разработки коленного сустава после травмы

Коленный сустав является одним из самых больших и сложных в организме человека. Вместе с тем это очень хрупкое сочленение, которое по частоте травм сопоставимо только с голеностопным суставом. Это объясняется высокой нагрузкой, которую колено выдерживает при ходьбе, катании на велосипеде и лыжах или игре в футбол, поскольку при движении оно несет вес всего тела. Травма коленного сустава — наиболее частая причина, по которой люди обращаются к врачу. При легких повреждениях проводится консервативное лечение, однако есть травмы, когда для восстановления необходимо проведение хирургической операции с последующей реабилитацией.

Причины травм коленного сустава

Чаще всего травмы колена бывают у спортсменов, но коленный сустав можно легко повредить даже в быту. Основными причинами бытового травматизма считаются:

- падение с высоты;
- резкое разгибание и сгибание колена;
- прыжки в высоту с приземлением на прямую ногу;
- удар твердым предметом в коленный сустав;

сустав: артроза и артрита, остеомиелита, остеопороза, воспаления костной ткани, вызванного нарушением синтеза коллагена, недостатка витаминов и минералов, других патологий.

Какие бывают травмы колена: наиболее распространенные случаи

Спортсменам и людям, чья работа связана с повышенными физическими нагрузками, следует знать, какие могут быть травмы колена. Наиболее распространенными повреждениями являются: ушиб, вывих, растяжение и разрыв медиальной или латеральной связки, переломы надколенника и костей (внешние и внутренние), нарушение целостности мениска.

сочленения вызывает схожие болевые ощущения, поэтому для уточнения диагноза необходимо обратиться к травматологу, который при помощи рентгенологического обследования или КТ точно определит, какая травма произошла у пациента.

Перелом колена

При падении, ДТП или ударе твердым предметом в коленном суставе может сломаться любая кость, но обычно происходит перелом коленной чашечки. Он сопровождается сильной болью, появлением отека, кровоизлиянием в полость сустава из-за разрыва кровеносных сосудов, невозможностью поднять прямую ногу. Диагноз подтверждается с помощью рентгенологического исследования. При переломе со смещением кости показано хирургическое вмешательство, во время которого отломки стягивают и соединяют между собой, используя пластины и винты. Если отломки находятся в анатомическом положении, рекомендуется ношение ортопедического фиксатора, удерживающего сустав в нужном положении, и проведение физиопроцедур.



Вывих колена

Вывих коленного сустава является серьезной травмой, при которой происходит смещение одной или нескольких костей относительно анатомического положения.

Причинами являются внезапное изменение направления во время падения, ДТП, резкий поворот колена под воздействием механической силы. Во многих случаях вывих бывает болезненным, но легко вправляется врачом-травматологом с последующим накладыванием шины.

Если в результате травмы повредились кровеносные сосуды и нервные волокна в области сочленения, возникает риск развития ишемических осложнений. В этом случае необходимо хирургическое лечение.

Ушиб колена

Ушиб коленного сустава — травматическое повреждение, полученное при падении, ударе тупым предметом или резком вращении туловища на фиксированной стопе, произошедшее без нарушения целостности структур сочленения. При ушибе страдают кожа, подкожная клетчатка, а также все внутрисуставные элементы. При легкой травме не происходит разрыва капилляров, из-за рефлекторного спазма и расширения сосудов наблюдаются отек и гематомы. При сильном ушибе бывает боль, сильное кровоизлияние, пораженные ткани пропитываются кровью. При ее попадании в суставную полость диагностируется гемартроз или синовит.

спортсменов, артистов балета, людей, выполняющих тяжелую физическую работу. При повреждении мениска невозможно согнуть и разогнуть ногу, возникают сложности с подъемом и спуском по ступенькам лестницы. Симптомами являются характерные щелчки, боль, отечность, ограниченность движений. При рентген-диагностике и МРТ в суставе обнаруживается скопление жидкости. При смещении хрящей врач-ортопед вставляет их на место и накладывает гипс или шину. При небольших надрывах выполняется артроскопия коленного сустава для снятия отека, удаления жидкости и восстановления подвижности. При обширных разрывах проводится операция по удалению мениска.

Разрыв сухожилия

Сухожильные соединения находятся под коленом и отвечают за сгибание и распрямление бедра, удержание тела в вертикальном положении при ходьбе. Провоцируют



інтенсивна біль в коліні і порушення ходьби, викликане труднощами підгибання ноги при ходьбі. Якщо виникли складності з підйомом випрямленої ноги, слід звернутися до травматолога або ортопеда, щоб зробити рентгенологічне обстеження і МРТ. При підтвердженні розриву пацієнту знадобиться операція з наступним накладенням гіпсу на коліно.

Растяжение связок колена

Травми зв'язок колінного суглава утворюються при підворачиванні голіні кнаружи або кнутри, при прямих ударах, падінні з висоти, ДТП, інших багатоконпонентних впливів. В момент отримання травми потерпілий відчуває щелчок і гостру біль. Підвищеність голіні порушується, можуть утворюватися припухлість і гематоми, з'явиться хромота, ознаки нестійкості суглава.

Діагностика свіжих травм проводиться під місцевою анестезією, призначаються рентген для виключення перелома, МРТ для послойного дослідження зв'язок, хрящів і сухожиль, УЗІ для виявлення об'єму синовіальної рідини. Ногою фіксують еластичним бинтом, в складних випадках призначають артроскопію колінного суглава.



Тендинит

Тендинит коленного сустава — воспалительный процесс, затрагивающий связку надколенника. Воспаление локализуется в зоне сухожилия, соединяющего коленную чашечку с голенью. Причинами заболевания являются микротравмы и постоянное перенапряжение сухожилия. Болезнь чаще всего диагностируется у спортсменов: легкоатлетов, футболистов, баскетболистов, теннисистов. Характеризуется сильной болью при экстремальных нагрузках, а также болевыми ощущениями при нажатии на связки в спокойном состоянии. Предрасполагающими факторами считаются: патология стоп, ношение неудобной обуви, травмы сустава, непродуманный график тренировок, прыжки на твердой поверхности, большой вес.

Факторы риска, приводящие к повреждению колена

К факторам риска, провоцирующим различные виды травм колена, относятся:

мышцы удерживают и защищают суставы от травм, способствуют увеличению амплитуды движений.

Застарелые травмы и воспаления. Плохо залеченные предыдущие травмы хрящей и костной ткани повышают риски получения новых повреждений.

Занятия активными видами спорта. Увеличивают нагрузку на коленный сустав и повышают риск получения травмы баскетбол, футбол, хоккей, горнолыжный спорт, бег трусцой.

Первая помощь при травмах коленного сустава

Тому, кто занимается спортом или выполняет работу, связанную с большими физическими нагрузками, важно знать, как определить, какая травма колена произошла, чтобы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Это стандартная процедура, при которой необходимо:

Обеспечить покой. Человека следует уложить на ровную жесткую поверхность и немного приподнять

уменьшит боль и отечность.

При сильных болевых ощущениях дать потерпевшему любой обезболивающий препарат.

Если произошел открытый перелом, остановить кровотечение, наложив на ногу жгут выше места повреждения с указанием времени. Через час жгут нужно ослабить и переложить немного выше.

Важно!

Нельзя самостоятельно вправлять сустав при вывихе, трогать костные отломки при открытом переломе или пытаться вставить их на место, прогревать колено в течение 48 часов после травмы, поскольку существует большой риск развития осложнений.



Лечение травм колена

медикаментов. Самыми серьезными считаются травма мениска колена, разрыв передней крестообразной связки и перелом коленного сустава. В отделении хирургии многопрофильного медицинского центра «Гарвис» применяются наиболее эффективные и безопасные способы лечения:

Металлоостеосинтез. Выполняется при многооскольчатых, околосуставных и внутрисуставных переломах костей. Во время операции травматолог-ортопед устанавливает металлические импланты, которые позволяют сопоставить и удержать костные отломки в правильном анатомическом положении, что способствует быстрому сращению поврежденной кости.

Артроскопия колена. Малоинвазивная операция, показаниями для которой являются как застарелые травмы, произошедшие более 1 месяца назад, так и свежие повреждения мениска, синовит и другие патологии. При артроскопии выполняются 2 небольших разреза, в один из которых вводится специальный раствор для промывания суставной полости, а в другой — артроскоп с микровидеокамерой. Врач видит изображение на мониторе и может выполнить необходимые манипуляции. Преимуществом артроскопии является отсутствие негативных последствий после процедуры.

Замена коленного сустава. Сложная эндоскопическая операция, во время которой поврежденный и изношенный сустав меняется на искусственный. Эндопротезирование проводится при неправильном сращении костей и неэффективности консервативных методов лечения артроза, некрозе костной ткани, ревматоидном полиартрите, гнойном воспалении сустава и других заболеваниях.



Упражнения для разработки коленного сустава после травмы

Очень часто люди интересуются, что делать для профилактики травм коленного сустава. Ответ достаточно прост. Уменьшить риск повторных повреждений и восстановить подвижность колена помогут массаж коленного сустава после травмы и выполнение комплекса упражнений:

Скольжение пяткой по полу. Упражнение выполняется в положении лежа на спине. Пятку, не отрывая от пола, нужно медленно переместить к ягодицам и медленно вернуть в исходное положение.

Сгибание поврежденного колена здоровой ногой. Подходит для раннего этапа реабилитации после травмы. Упражнение делают сидя на стуле. Располагая здоровую ногу над больной, стараются максимально согнуть поврежденный коленный сустав.

Сгибание колена с помощью ремня. Пациент сидит на стуле и упирается на здоровую ногу. Голеностоп травмированной ноги закрепляется ремнем, который обернут вокруг ножки стула, свободный конец находится в руке. Нужно тянуть ремень на себя, чтобы травмированное колено сгибалось до появления боли в области бедра.

Феськова Татьяна Николаевна

Терапевт



Другие статьи

Все публикации



ХИРУРГИЯ

13 марта 2024

Рак анального канала:
симптомы, диагностика,
методы лечения

ДИАГНОСТИКА

13 марта 202

Полипы желчного пузь

Направления	Garvis	Пациентам	К
Семейная медицина	О сети	Цены	У
Профильные специалисты	Администрация	Акции	У
Диагностика	Лицензии и сертификаты	Новости	+ 10
Хирургия	Партнеры	Контакты	+ 10

Check-Up **New**

Garvis© 1997-2024. Все права
захищені.

Правила внутрішнього
розпорядка

